

TEMA 3.3 • OBSTETRICIA

Anemia en el Embarazo

PERFIL EUNACOM 2.01.2.012  
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

# Anemia en el Embarazo

Definición: Anemia Fisiológica del Embarazo

En el embarazo hay **hemodilución fisiológica** (↑ volumen plasmático > ↑ masa eritrocitaria), por lo que los valores normales de Hb son más bajos que en la mujer no embarazada.

| TABLA 3.3.1: PERÍODO VS HB NORMAL MÍNIMA |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| PERÍODO                                  | HB NORMAL MÍNIMA                |
| General (1er y 3er trimestre)            | ≥ 11 g/dL                       |
| 2do trimestre                            | ≥ 10.5 g/dL (nadir fisiológico) |
| Postparto                                | ≥ 10 g/dL                       |

**PERLA CLÍNICA EUNACOM**  
**Regla práctica:** Hb < 11 = anemia en embarazada (excepto 2do trimestre donde el corte es 10.5). El hematocrito equivale aproximadamente a Hb × 3.

Causa más Frecuente: Anemia Ferropénica

La anemia ferropénica es la causa más frecuente de anemia en el embarazo.

**Diagnóstico:** Clínico + Hb bajo el corte según trimestre. No se requieren estudios de hierro para iniciar tratamiento en contexto de embarazo.

Profilaxis (Toda Embarazada)

| TABLA 3.3.2: SUPLEMENTO VS DOSIS |                                       |                 |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| SUPLEMENTO                       | DOSIS                                 | INICIO          |
| Sulfato ferroso                  | 200 mg/día (= 40 mg hierro elemental) | Desde semana 16 |

**NOTA CLÍNICA**  
La dosis de hierro elemental se calcula dividiendo la dosis de sulfato ferroso por 5: 200 mg sulfato ferroso ÷ 5 = **40 mg hierro elemental**. Esta es la dosis profiláctica. Si hay anemia, se triplica.

Tratamiento de la Anemia Ferropénica

Anemia confirmada (Hb bajo el corte)

- **Primera línea: Vía oral — triple dosis**
- Sulfato ferroso ~200 mg **c/8 horas** (= ~120 mg hierro elemental/día)

Indicaciones de Hierro Endovenoso (EV)

- **Intolerancia oral** (náuseas, vómitos, epigastralgia)
- **Anemia severa** (sin tiempo suficiente para responder a vía oral)
- **Final del embarazo** (no hay tiempo para respuesta oral antes del parto)

Indicación de Transfusión

- **Anemia sintomática severa** (mismo criterio que en paciente no embarazada)
- Síntomas: taquicardia, hipotensión, disnea, angor, mareo severo

**ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN**  
La transfusión se reserva para casos extremos (anemia sintomática severa). No se transfunde solo por un número bajo de Hb sin síntomas.

**CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**

**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**  
"En relación a Anemia en el Embarazo: Período | Hb normal mínima | ---|---| General (1er y 3er trimestre) | ≥ 11 g/... ¿cuál es la conducta correcta?"

**EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:**  
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Anemia en el Embarazo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

**PUNTOS CLAVE DESTACADOS**

- Definición: Anemia Fisiológica del Embarazo
- Causa más Frecuente: Anemia Ferropénica
- Profilaxis (Toda Embarazada)
- Tratamiento de la Anemia Ferropénica
- Anemia confirmada (Hb bajo el corte)
- Indicaciones de Hierro Endovenoso (EV)
- Indicación de Transfusión

## EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ANEMIA EN EL EMBARAZO)

## PREGUNTA 1

En relación a Anemia en el Embarazo: Período | Hb normal mínima | |---|---| | General (1er y 3er trimestre) |  $\geq 11$  g/... ¿cuál es la conducta correcta?

- A) El diagnóstico de Anemia en el Embarazo se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B) El manejo inicial de Anemia en el Embarazo debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C) Todo paciente con Anemia en el Embarazo requiere hospitalización inmediata
- D) El tratamiento de Anemia en el Embarazo es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E) El seguimiento de Anemia en el Embarazo no es necesario una vez iniciado el tratamiento

## PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Anemia en el Embarazo?

- A) Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B) Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C) Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D) Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E) Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

## PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Anemia en el Embarazo. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A) Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B) Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C) Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D) Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E) Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

## RESUMEN: ANEMIA EN EL EMBARAZO

En el embarazo hay hemodilución fisiológica ( $\uparrow$  volumen plasmático  $>$   $\uparrow$  masa eritrocitaria), por lo que los valores normales de Hb son más bajos que en la mujer no embarazada. ::tip Regla práctica:  $Hb < 11$  = anemia en embarazada (excepto 2do trimestre donde el corte es 10.5). El hematocrito equivale aproximadamente a  $Hb \times 3$ . ::: Diagnóstico: Clínico + Hb bajo el corte según trimestre. No se requieren estudios de hierro para iniciar tratamiento en contexto de embarazo.